Κοστολόγηση Περιστατικών ΤΑ.ΕΠ. — μη δικαιούχοι ΓεΣΥ

Ερωτήματα μετά τη δοκιμή της 21/10/2026

Προς: Μονάδα Ελέγχου Εσόδων
Από: Τμήμα Πληροφορικής
Ημερομηνία: 21/10/2026

Από τη δοκιμή προέκυψαν οκτώ παρατηρήσεις. Τις πέντε τις διορθώνουμε μόνοι μας και δεν χρειάζονται απόφαση. Επτά σημεία χρειάζονται τη δική σας τοποθέτηση, και τα δύο πρώτα αφορούν χρήματα.

Τι διορθώθηκε ήδη, χωρίς να χρειάζεται απόφαση

- Η προκαταβολή εμφανίζεται πλέον στην οθόνη και στο έντυπο, με το υπόλοιπο προς είσπραξη από κάτω.
- Όλες οι λίστες επιλογής δέχονται πληκτρολόγηση για αναζήτηση. Η Χώρα έχει 257 επιλογές και μέχρι τώρα έβρισκες μόνο με το πρώτο γράμμα.
- Η οθόνη διόρθωσης στοιχείων και οι πλήρεις κατάλογοι πράξεων είναι υπό κατασκευή· τα ερωτήματα 6 και 7 αφορούν τον κανόνα, όχι την υλοποίηση.

Ερωτήματα

1. Τέλος εγγραφής: χρεώνεται ξανά στην έξοδο;

Στις 29/09/2026 μας δώσατε ότι το τέλος εγγραφής των 10 € ισχύει στις κατηγορίες 603, 605, 608. Το εφαρμόσαμε και προστίθεται στο σύνολο της κοστολόγησης.

Στη δοκιμή της 21/10 αναφέρθηκε το αντίθετο: ότι το τέλος εισπράττεται ήδη κατά την εγγραφή του ασθενή, μέσω Medico ή PlanB, και δεν πρέπει να ξαναχρεώνεται στην έξοδο.

Τα δύο δεν συμβιβάζονται, και η διαφορά είναι πραγματικά χρήματα σε κάθε περιστατικό αυτών των κατηγοριών. Δεν αλλάζουμε απόφαση που μας δώσατε γραπτώς χωρίς νέα απόφαση.

Και οι δύο λύσεις είναι μικρές σε υλοποίηση. Είτε το τέλος παραμένει στο σύνολο όπως σήμερα, είτε εμφανίζεται ως ήδη εισπραγμένο και αφαιρείται από το πληρωτέο, όπως κάνουμε ήδη με την προκαταβολή.

Ζητούμενο: **Το τέλος εγγραφής χρεώνεται στην κοστολόγηση εξόδου, ή εισπράττεται αποκλειστικά κατά την εγγραφή και εμφανίζεται μόνο ενημερωτικά;**

Απάντηση Μονάδας Ελέγχου Εσόδων

2. Ευρωκάρτα και Βρετανικές Βάσεις: ποια είναι η επιπληρωμή;

Οι κατηγορίες υπάρχουν ήδη: 602 ΕΥΡΩΚΑΡΤΑ και 640 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, και στις δύο ισχύουν οι χρεώσεις τιμοκαταλόγου.

Αυτό που δεν έχουμε είναι ο κανόνας της επιπληρωμής. Κανείς δεν μας έχει δώσει ποσοστό, ποσό ή βάση υπολογισμού, και δεν τα υποθέτουμε.

Χρειαζόμαστε τρία πράγματα για να το προγραμματίσουμε: σε ποιες κατηγορίες ισχύει, πώς υπολογίζεται, και πάνω σε ποιο ποσό εφαρμόζεται — στο κόστος βαρύτητας, στις χρεώσεις τιμοκαταλόγου, ή στο σύνολο.

Ζητούμενο: **Ποιος είναι ο κανόνας επιπληρωμής για την Ευρωκάρτα και για τις Βρετανικές Βάσεις, και σε ποια βάση εφαρμόζεται;**

Απάντηση Μονάδας Ελέγχου Εσόδων

3. Προκαταβολή 100 €: επιβεβαίωση του τρόπου εμφάνισης

Στις 29/09/2026 ορίσατε ότι τα 100 € στην κατηγορία 600 ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ είναι προκαταβολή και δεν προστίθενται στην κοστολόγηση. Έτσι ακριβώς υπολογίζεται.

Στη δοκιμή αναφέρθηκε ότι η προκαταβολή δεν φαινόταν πουθενά. Είχε δίκιο: την υπολογίζαμε και δεν την εμφανίζαμε. Τώρα τυπώνεται σε δική της γραμμή κάτω από το τελικό κόστος, μαζί με το υπόλοιπο προς είσπραξη. Το σύνολο δεν άλλαξε.

Παράδειγμα από το σύστημα: Τελικό Κόστος 120,00 €, Προκαταβολή 100,00 €, Υπόλοιπο προς είσπραξη 20,00 €.

Ζητούμενο: Επιβεβαιώνετε ότι η εμφάνιση αυτή είναι σωστή, και ότι το ταμείο εισπράττει το υπόλοιπο και όχι το τελικό κόστος;

Απάντηση Μονάδας Ελέγχου Εσόδων

4. Ποιες μονάδες ΤΑΕΠ βλέπει ο κάθε χρήστης;

Στη δοκιμή αναφέρθηκε ότι εμφανίζονται μόνο δύο μονάδες. Αυτό είναι το σχεδιασμένο: ο χρήστης βλέπει τις μονάδες του δικού του νοσηλευτηρίου, και ο λογαριασμός της δοκιμής ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, που λειτουργεί δύο — ενηλίκων 1054 και παίδων 1106.

Ο κανόνας αυτός είναι σκόπιμος: καταχωρητής της Λεμεσού δεν πρέπει να βλέπει ούτε να κοστολογεί περιστατικό της Λευκωσίας.

Υπάρχει όμως ερώτημα για τους κεντρικούς ρόλους. Στο eFinance, ορισμένοι ρόλοι βλέπουν ήδη όλα τα νοσηλευτήρια. Αν η Μονάδα θέλει να μπορεί να καταχωρεί ή να ελέγχει περιστατικά οποιουδήποτε νοσηλευτηρίου, το προσθέτουμε για αυτούς τους ρόλους και μόνο.

Ζητούμενο: Οι κεντρικοί χρήστες πρέπει να μπορούν να επιλέγουν μονάδα οποιουδήποτε νοσηλευτηρίου, ή παραμένει ο περιορισμός για όλους;

Απάντηση Μονάδας Ελέγχου Εσόδων

5. Διαγνώσεις και ICD-10

Ζητήθηκε πεδίο διάγνωσης με κατάλογο ICD-10. Δεν υπάρχει σήμερα, και δεν ήταν στην αρχική περιγραφή του έργου.

Σημειώνουμε ότι η διάγνωση δεν επηρεάζει την τιμή. Ο αλγόριθμος του ΟΑΥ βγάζει τη βαρύτητα από τις υπηρεσίες που επιλέγονται, όχι από τη διάγνωση. Άρα το πεδίο είναι για καταγραφή, όχι για κοστολόγηση — κάτι που αλλάζει πόσο αυστηρά πρέπει να ελέγχεται.

Για να το φτιάξουμε χρειαζόμαστε τον κατάλογο που θεωρείται επίσημος για τον ΟΚΥπΥ. Το ICD-10 έχει δεκάδες χιλιάδες κωδικούς και κυκλοφορεί σε παραλλαγές. Αν υπάρχει ήδη κατάλογος σε χρήση στο Medico ή στο PlanB, προτιμούμε αυτόν, ώστε οι κωδικοί να ταιριάζουν μεταξύ των συστημάτων.

Ζητούμενο: Είναι υποχρεωτική η διάγνωση για την κοστολόγηση; Και ποιον κατάλογο ICD-10 χρησιμοποιούμε — υπάρχει αρχείο που μπορείτε να μας δώσετε;

Απάντηση Μονάδας Ελέγχου Εσόδων

6. Διόρθωση στοιχείων μετά την καταχώρηση

Αναφέρθηκε ότι δεν γίνεται διόρθωση λάθους στοιχείου. Σωστό, και το φτιάχνουμε — ο μηχανισμός υπάρχει ήδη, λείπει η οθόνη.

Πριν το κλειδώσουμε χρειαζόμαστε τον κανόνα. Όσο η κοστολόγηση δεν έχει οριστικοποιηθεί, η διόρθωση είναι απλή και δεν θίγει τίποτα.

Μετά την οριστικοποίηση αλλάζει το πράγμα, γιατί έχει εκδοθεί αριθμός κοστολόγησης και έχει τυπωθεί έγγραφο. Η οικονομική κατηγορία ειδικά καθορίζει την τιμή: αλλαγή της μετά την οριστικοποίηση σημαίνει άλλο ποσό από αυτό που έχει ήδη δοθεί στον ασθενή. Για τηλέφωνο ή διεύθυνση δεν ισχύει το ίδιο.

Ζητούμενο: Μετά την οριστικοποίηση, ποια πεδία επιτρέπεται να διορθωθούν χωρίς ακύρωση και επανακαταχώρηση, και ποιος έχει το δικαίωμα;

Απάντηση Μονάδας Ελέγχου Εσόδων

7. Κατάλογοι θεραπειών και εξετάσεων

Ζητήθηκαν πλήρεις κατάλογοι με δυνατότητα αναζήτησης, ώστε το γραμματειακό προσωπικό να βρίσκει την πράξη χωρίς ιατρική γνώση. Το φτιάχνουμε.

Και οι 125 υπηρεσίες έχουν ήδη περιγραφή στα ελληνικά και στα αγγλικά, οπότε η αναζήτηση θα δέχεται και τα δύο.

Ένα σημείο θέλει απόφαση: αν η αγγλική περιγραφή πρέπει να φαίνεται δίπλα στην ελληνική στην οθόνη, ή μόνο να συμμετέχει στην αναζήτηση. Το έντυπο που παίρνει ο ασθενής παραμένει στα ελληνικά σε κάθε περίπτωση.

Ζητούμενο: Να εμφανίζεται και η αγγλική περιγραφή στην οθόνη επιλογής, ή αρκεί να λειτουργεί στην αναζήτηση;

Απάντηση Μονάδας Ελέγχου Εσόδων

Τα ερωτήματα 1 και 2 κρατούν πίσω την παραγωγική λειτουργία, γιατί και τα δύο καθορίζουν ποσά που θα ζητηθούν από ασθενείς. Τα υπόλοιπα μπορούν να απαντηθούν παράλληλα με τη δοκιμή.